

Nếu bạn đang cân nhắc phẫu thuật điều trị sa tạng chậu, có một số lựa chọn cần cùng bác sĩ quyết định. Thường **không có một câu trả lời “đúng” duy nhất** — kế hoạch tốt nhất phụ thuộc vào giải phẫu, sức khỏe và điều quan trọng nhất với bạn. Tờ thông tin này giúp bạn chuẩn bị cho cuộc trò chuyện đó.

Các quyết định chính

- **Tái tạo hay đóng kín** — xây dựng lại hỗ trợ (tái tạo) và giữ âm đạo thông thoáng, hoặc đóng kín âm đạo (colpocleisis) nếu bạn không có kế hoạch quan hệ tình dục qua âm đạo.
- **Đường vào** — qua đường âm đạo, hoặc qua đường bụng bằng phẫu thuật nội soi/robot.
- **Tử cung** — cắt bỏ (cắt tử cung) hoặc giữ lại bằng phẫu thuật treo tử cung (hysteropexy).
- **Vật liệu hỗ trợ** — mô tự thân, mảnh ghép sinh học, hoặc lưới (lưới đường bụng như trong sacrocolpopexy).
- **Tiểu không kiểm soát** — có cần thêm thủ thuật chống rò rỉ ngay lúc này không (xem bên dưới).

Về tình trạng tiểu không kiểm soát ẩn

Đôi khi sa tạng lớn **che giấu** tình trạng tiểu không kiểm soát khi gắng sức (SUI) vốn chỉ xuất hiện sau khi đã sửa sa tạng (“SUI ẩn”). Nhóm chăm sóc có thể kiểm tra điều này và trao đổi xem có nên đặt băng nâng cùng lúc hay đợi sau.

GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ

Tái tạo

Xây dựng lại hỗ trợ, giữ âm đạo hoạt động bình thường.

Đóng kín (obliterative)

Đóng kín âm đạo (colpocleisis) — rất bền vững, chấm dứt quan hệ tình dục qua âm đạo.

Hysteropexy

Phẫu thuật treo tử cung (giữ lại tử cung).

Sửa chữa bằng mô tự thân

Phẫu thuật chỉ dùng mô của chính bạn, không cần mảnh ghép.

SUI ẩn

Tiểu không kiểm soát khi gắng sức bị che giấu, xuất hiện sau khi sửa sa tạng.

Tái phát

Khả năng sa tạng trở lại theo thời gian.

LÀM SAO ĐỂ CHỌN? Bằng cách đối chiếu các lựa chọn với **ưu tiên của bạn** — độ bền, thời gian hồi phục, giữ tử cung, hoạt động tình dục, và quan điểm của bạn về lưới. Bác sĩ sẽ tư vấn phương án phù hợp với giải phẫu và sức khỏe; “lựa chọn tốt nhất” là lựa chọn phù hợp với mục tiêu của bạn sau khi đã trao đổi rõ ràng.

Câu hỏi nên hỏi bác sĩ

- Bác sĩ khuyến nghị **phương pháp nào** cho tôi, và tại sao?
- **Đường âm đạo hay đường bụng** — và thời gian hồi phục mỗi cách như thế nào?
- Tôi có thể (hoặc có nên) **giữ lại tử cung** không?
- Bác sĩ sẽ dùng **mô tự thân, mảnh ghép hay lưới** — và rủi ro là gì?
- Tôi có cần thủ thuật **chống tiểu không kiểm soát** ngay bây giờ hay sau này?
- Tỷ lệ **tái phát** là bao nhiêu, và nếu tái phát thì xử lý thế nào?

Cũng nên biết

- **Vòng nâng (pessary)** luôn là lựa chọn không phẫu thuật nếu bạn muốn tránh hoặc trì hoãn phẫu thuật.
- Kiểm soát cân nặng, táo bón, ho mạn tính và (sau mãn kinh) bổ sung estrogen âm đạo có thể cải thiện kết quả phẫu thuật.

Cách chuẩn bị

- Hoàn thành các **xét nghiệm trước mổ** và mang theo danh sách thuốc đang dùng.
- Lên kế hoạch **bỏ thuốc lá** và sắp xếp người hỗ trợ tại nhà.
- Ghi nhớ quy tắc hồi phục chung: tránh nâng vật nặng và quan hệ tình dục khoảng 6 tuần.

Báo nhóm chăm sóc trước phẫu thuật nếu bạn:

- Đang dùng **thuốc chống đông** hoặc có rối loạn chảy máu
- Đang có **nhiễm trùng** đường tiết niệu hoặc âm đạo
- Có **đau vùng chậu, chảy máu, hoặc vết loét không lành** trên khối sa

BA ĐIỀU CẦN NHỚ

1. Phẫu thuật sửa chữa sa tạng có nhiều lựa chọn — tái tạo hay đóng kín, đường vào, giữ tử cung, vật liệu hỗ trợ và xử lý tiểu không kiểm soát ẩn.
2. Hiếm khi có một đáp án duy nhất đúng; kế hoạch tốt nhất phải phù hợp với giải phẫu và ưu tiên của bạn.
3. Hãy đặt các câu hỏi quan trọng và nhớ rằng vòng nâng luôn là lựa chọn không phẫu thuật.